

1.5 Product Information

1.5.1 Prescribing information (Summary of products characteristics)

Enclosed

AARLOFLOX OZ (comprimés d'ofloxacine et d'ornidazole)

Résumé des caractéristiques du produit

1.1 Nom du médicament**a. Nom du produit**

AARLOFLOX OZ (comprimés d'ofloxacine et d'ornidazole)

b. Dosage

200 mg + 500 mg

c. Forme galénique pharmaceutique

Comprimés pour administration orale

1.2 Qualité et composition quantitative

Chaque comprimé pelliculé contient:

Ofloxacine USP 200 mg

Ornidazole 500 mg

Excipients q.s.

1.3 Forme pharmaceutique: comprimé

Description visuelle: Comprimé pelliculé biconvexe en forme de caplet de couleur orange uni des deux côtés.

1.4 Données cliniques**a. Indication thérapeutique**

AARLOFLOX OZ est indiqué dans le traitement empirique des infections mixtes aérobie-anaérobie couramment observées en pratique clinique, telles que les infections intra-abdominales, les infections gynécologiques et pelviennes, les ulcères du pied, en particulier du diabète, les abcès du poumon, les infections des patients immunodéprimés, etc.

b. Posologie et administration de la méthode

Un comprimé d'AARLOFLOX OZ est recommandé en traitement bi-quotidien.

c. Contre-indication

Ofloxacin ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une hypersensibilité connue aux antibactériens 4-quinolone ou à l'un des excipients du comprimé.

L'ofloxacine ne doit pas être utilisée chez les patients ayant des antécédents de tendinite. L'ofloxacine, comme les autres 4-quinolones, est contre-indiquée chez les patients ayant des antécédents d'épilepsie ou un seuil de crise réduit. L'ofloxacine est contre-indiquée chez les enfants et les adolescents en croissance ainsi que chez les femmes enceintes ou allaitantes, car les expériences sur les animaux n'excluent pas totalement le risque de lésion du cartilage des articulations chez le sujet en croissance.

Les patients présentant des anomalies réelles ou latentes de l'activité du glucose-6-phosphate déshydrogénés peuvent être sujets à des réactions hémolytiques lorsqu'ils sont traités avec des agents antibactériens quinolones.

l'ornidazole ou l'un des composants de cette formulation, une maladie rénale active ou une cirrhose hépatique.

Patients présentant une hypersensibilité connue à l'ornidazole ou à l'un des composants de cette formulation, à une insuffisance rénale active ou à une cirrhose hépatique.

d. Mises en garde spécial et précautions d'emploi

Ofloxacine: Les patients traités à l'ofloxacine ne doivent pas s'exposer inutilement à la lumière directe du soleil et doivent éviter les rayons UV (lampes solaires, solariums). La prudence est recommandée si le médicament doit être utilisé chez des patients psychotiques ou chez des patients ayant des antécédents de maladie psychiatrique¹. L'administration d'antibiotiques, en particulier de longue durée, peut entraîner la prolifération de micro-organismes résistants. L'état du patient doit donc être vérifié à intervalles réguliers. Si une infection secondaire se produit, des mesures appropriées doivent être prises¹.

AARLOFLOX OZ (comprimés d'ofloxacin et d'ornidazole)

Ornidazole: Des tests de laboratoire et un contrôle clinique réguliers sont indiqués en cas d'utilisation de fortes doses d'ornidazole ou si la durée du traitement dépasse 10 jours. Troubles sanguins: le nombre de leucocytes doit être vérifié avant et après le début du traitement (en particulier lors d'un traitement répété) chez les patients ayant des antécédents de troubles sanguins.

SNC: Les maladies graves du système nerveux central et périphérique peuvent être aggravées par le traitement par ornidazole. Le traitement doit être interrompu en cas d'apparition de neuropathie périphérique, d'ataxie, de vertige ou de confusion.

Candidose: le traitement par Ornidazole peut aggraver la candidose existante. Les précautions nécessaires doivent être prises.

e. Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions

Ofloxacin: L'administration concomitante d'antiacides magnésium-aluminium, de sucralfate ou de préparations à base de fer peut réduire l'absorption. Par conséquent, l'ofloxacin doit être prise 2 heures avant de telles préparations. Une prolongation du temps de saignement a été rapportée lors de l'administration concomitante d'ofloxacin et d'anticoagulants. Le seuil d'épilepsie cérébrale peut encore être abaissé lorsque des quinolones sont administrées en même temps que d'autres médicaments abaissant le seuil d'épilepsie, par exemple. Théophylline. Cependant, on ne pense pas que l'ofloxacin provoque une interaction pharmacocinétique avec la théophylline, contrairement à d'autres fluoroquinolones. Un abaissement supplémentaire du seuil d'épilepsie cérébrale peut également survenir avec certains médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens. L'ofloxacin peut entraîner une légère augmentation des concentrations sériques de glibenclamide administré simultanément; les patients traités avec cette association doivent être étroitement surveillés. Aux fortes doses de quinolones, une insuffisance d'excrétion et une augmentation des taux sériques peuvent survenir lors d'une administration concomitante avec d'autres médicaments subissant une sécrétion tubulaire rénale (probenécide, cimétidine, furosémide et méthotrexate). Interaction avec des tests de

laboratoire: Détermination des opiacés ou des porphyrines dans

l'urine peut donner des résultats faussement positifs pendant le traitement par ofloxacin.

Ornidazole: Intolérance à l'alcool: contrairement aux autres nitro-imidazoles, l'ornidazole n'inhibe pas l'enzyme aldéhyde déshydrogénase. Aucune réaction de type disulfam n'a été rapportée sur la consommation d'alcool.

Cependant, comme c'est le cas pour tous les imidazoles, ce médicament doit être évité en association avec la consommation d'alcool. Aucune interaction cliniquement significative n'a été observée avec les aliments et aucune interaction n'a été constatée entre l'ofloxacin et la théophylline.

F. Grossesse et allaitement

Aucune étude contrôlée de l'effet du médicament sur les femmes enceintes n'est disponible. Ornidazole doit être prescrit aux femmes enceintes et allaitantes uniquement si les avantages potentiels pour la mère l'emportent sur les avantages potentiels.

risque pour le fœtus / nouveau-né. Lithothérapie: on a constaté que les 5-nitroimidazoles (principalement le métronidazole) diminuaient l'élimination rénale du lithium. Ainsi, chez les patients qui suivent un traitement concomitant au lithium, les concentrations plasmatiques de lithium ainsi que les concentrations de créatinine et d'électrolytes doivent être surveillées.

Aarlofox OZ doit être utilisé avec prudence dans des conditions où les médicaments individuels ont été utilisés avec une approche de précaution.

g. Effets indésirables

Ofloxacin: La fréquence globale des réactions indésirables tirée de la base de données des essais cliniques est d'environ 7%. Les événements les plus courants concernaient le système gastro-intestinal (environ 5,0%) et le système nerveux (environ 2,0%). Vous trouverez ci-après un tableau basé sur l'expérience acquise après la commercialisation, où la fréquence occasionnelle représente une fréquence de 0,1 à 1,0%, rare <0,1%, très rare <0,01% et cas isolés <0,01%.

Occasionnel: Nausées et vomissements, diarrhée, douleurs abdominales, symptômes gastriques. (La diarrhée peut parfois être un symptôme d'entérococolite qui peut, dans certains cas, être hémorragique).

Rare: perte d'appétit, augmentation des enzymes hépatiques et / ou de la bilirubine. jaunisse cholestatique; Une hépatite ou des lésions hépatiques graves peuvent se développer. Une forme particulière d'entérococolite qui peut survenir avec des antibiotiques est la colite pseudomembraneuse (dans la plupart des cas due à Clostridium difficile).

AARLOFLOX OZ (comprimés d'ofloxacin et d'ornidazole)

Même si l'on ne soupçonne que *Clostridium difficile*, l'administration d'oxacine doit être immédiatement interrompue et un traitement approprié administré. Les médicaments qui inhibent le péristaltisme ne doivent pas être administrés dans de tels cas.

h. Surdosage et antidotes spéciaux

Les signes les plus importants à prévoir après un surdosage aigu sont les symptômes du système nerveux central, tels que la confusion, les vertiges, l'altération de la conscience et les convulsions, ainsi que des réactions gastro-intestinales, telles que nausées et érosions des muqueuses. En cas de surdosage, éliminez toute oxoxine non absorbée, par ex. un lavage gastrique, l'administration d'adsorbants et de sulfate de sodium, si possible au cours des 30 premières minutes, sont recommandés; les antiacides sont recommandés pour la protection de la muqueuse gastrique. L'élimination de l'ofloxacin peut être augmentée par une diurèse forcée. En cas de surdosage, le patient doit être surveillé attentivement et un traitement symptomatique doit être administré. L'estomac doit être vidé par lavage gastrique ou vomissements. Toutes les mesures de soutien et l'hydratation doivent être maintenues. En cas de convulsions, le diazépam par voie intraveineuse est recommandé.

1.5 Propriétés pharmacologiques Caractéristiques cliniques**a. Propriétés pharmacodynamiques**

Ofloxacin: Il est actif après une administration orale. Il inhibe la réplication de l'ADN bactérien en bloquant les ADN topoisomérases, en particulier l'ADN gyrase. Les doses thérapeutiques d'ofloxacin sont dépourvues d'effets pharmacologiques sur le système nerveux volontaire ou autonome.

Ornidazole: après absorption passive dans une cellule bactérienne, le groupe nitro d'ornidazole est réduit en groupe amine par le système redox de type ferredoxine. On pense que la formation de métabolites intracellulaires intermédiaires d'oxydo-réduction est la principale composante de la destruction des micro-organismes par Ornidazole. Le mécanisme d'action est similaire chez les protozoaires.

Microbiologie: Les résultats microbiologiques indiquent que les agents pathogènes suivants peuvent être considérés comme sensibles: *Staphylococcus aureus* (y compris le staphylocoque résistant à la thicilline),

Staphylococcus epidermidis, espèces de *Neisseria*, *Escherichia coli*, *Citrobacter*, *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Hafnia*, *Proteus* (souches indoles négatives et indoles positives), *Haemophilus influenzae*, *Chlamydiae*, *Leglamella*, *Gardionella*. Les streptocoques, *Serratia marcescens*, *Pseudomonas aeruginosa* et *Mycoplasmas* montrent une sensibilité variable.

Les bactéries anaérobies (par exemple les espèces *Fusobacterium*, les espèces *Bacteroides*, les espèces *Eubacterium*, les peptocoques, les peptostreptocoques) sont normalement résistantes. L'ofloxacin n'est pas active contre *Treponema Pallidum*.

b. Propriétés pharmacocinétiques

Ofloxacin: L'ofloxacin est presque complètement absorbée après administration orale. Les concentrations sanguines maximales sont atteintes 1 à 3 heures après l'administration et la demi-vie d'élimination est de 4 à 6 heures. L'ofloxacin est principalement excrétée sous forme inchangée dans les urines. En cas d'insuffisance rénale, la dose doit être réduite.

Ornidazole: L'ornidazole est facilement absorbé par la GIT et des concentrations plasmatiques maximales d'environ 30 µg / ml sont atteintes dans les 2 heures qui suivent une dose unique de 1,5 g. L'alimentation n'affecte pas l'étendue mais le taux d'absorption de l'ornidazole. L'ornidazole est lié à moins de 15% aux protéines plasmatiques. Il est largement distribué dans les tissus corporels et les fluides, y compris le fluide cérébrospinal. Les concentrations antibactériennes sont atteintes dans les sécrétions vaginales, les fluides amniotiques, les appendices et les tissus intestinaux. Plus de 90% de la dose d'ornidazole est métabolisée dans le foie. Les métabolites sont actifs et ont la même activité que l'ornidazole contre les bactéries anaérobies. La demi-vie d'élimination ($t_{1/2}$) de l'ornidazole est de 12 à 14 heures. Il est excrété dans les urines, principalement sous forme de conjugués et de métabolites et, dans une moindre mesure, dans les fèces. L'excrétion biliaire peut jouer un rôle important dans l'élimination de l'ornidazole et de ses métabolites. Justification de la combinaison d'oxoxine et d'ornidazole

Peu d'études ont montré que l'association de nitroimidazoles et de quinolones était efficace sur le plan clinique. Cela donne une indication pour combiner l'ornidazole et l'ofloxacin spécialement dans les infections mixtes. Ornidazole, un nouveau dérivé de la série nitroimidazole, a une demi-vie plus longue. Il est recommandé de l'administrer deux

AARLOFLOX OZ (comprimés d'ofloxacin et d'ornidazole)

fois par jour. L'ofloxacin est également recommandée deux fois par jour. Par conséquent, il semble approprié d'associer l'ornidazole et l'ofloxacin en combinaisons de doses dosefixées. De plus, FDC fournira un large spectre de l'activité en tant que médicaments individuels qui sont actifs à la fois contre les infections aérobie et anaérobies.

1.6 Particularités pharmaceutiques**a. Liste des excipients**

1	Amidon de maïs BP
2	Glycolate d'amidon de sodium BP
3	Stéarate de magnésium BP
4	Talc BP
5	Silice colloïdale anhydre BP
6	Crosscarmellose sodique BP
7	Cellulose microcristalline BP
8	Sheffcoat Orange 5Y600768 Maison
9	Eau purifiée BP

b. Des incompatibilités

Aucun

c. Durée de vie

36 mois

Durée de conservation après dilution ou reconstitution conformément aux instructions.

Non applicable

Durée de vie après première ouverture.

Non applicable.

d. Précaution spéciale pour le stockage

Conserver au-dessous de 30°C. Protéger de la lumière.

e. Nature et contenu du récipient

Blister de comprimés Alu-Alu de 10'S. Ces 1 blisters Alu-Alu sont emballés dans un carton imprimé avec l'insert d'emballage.

1.7 Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché**Pinnacle Life Science Pvt. Ltd**

Mahendra Industrial Estate, 3ème étage

Lot no .109-D, Rd no 29

Sion (Est), Mumbai 400 022, Inde

1.8 Numéro d'autorisation de mise sur le marché:

MNB / 08/729

1.9 Nom du fabricant:**Pinnacle Life Science Pvt. Ltd**

Khasra n ° 1328-1330, Village Manpura, Tehsil-Baddi,

Distt. Solan, Himachal Pradesh (H.P.) - 174101, Inde.

AARLOFLOX OZ (comprimés d'ofloxacine et d'ornidazole)

1.10 Date de première autorisation / renouvellement de l'autorisation

20-03-2014

1.11 Date de la révision du texte-----